

9.62.Pomalidomide(如 Pomalyst):(107/1/1、109/2/1、112/4/1、113/9/1)

- 1.與 dexamethasone 合併使用，核准用於多發性骨髓瘤病人，且先前接受過含 lenalidomide 和 bortezomib 在內的至少兩種療法，且確認完成前次治療時或結束治療後六十天內發生疾病惡化(disease progression)。
- 2.限與 elotuzumab 及 dexamethasone 併用，治療之前曾接受過至少兩種療法（包括 lenalidomide 和蛋白酶體抑制劑）的多發性骨髓瘤成年病人。
(113/9/1)
- 3.需經事前審查核准後使用：(107/1/1、112/4/1)
 - (1)初次申請以3個療程為限，且需同時符合下列I.與II.的條件：(112/4/1)
 - I.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標（但若為 plasmacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s) 或新 plasmacytoma，則僅需1次評估）：(112/4/1)
 - i.若前一線治療中 M component 最低值 ≥ 5 g/dL，血清 M 蛋白需增加 ≥ 1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值 < 5 g/dL，血清 M 蛋白需增加 ≥ 0.5 g/dL。
 - ii.Urine M-protein 需增加 ≥ 0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加 $\geq 25\%$ 。
 - iii.在 non-secretory myeloma 病人，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加 $\geq 10\%$ ，且需較前一線治療中的最低值增加 $\geq 25\%$ 。
 - iv.新產生的 bone lesion(s)或 plasmacytoma；且須經病理切片證實。
 - v.Plasmacytoma 體積增加 $\geq 50\%$ 。
 - vi.周邊血液中漿細胞比例 $\geq 20\%$ 或漿細胞絕對值 ≥ 2000 cells/ μ L。
 - II.出現下列任一臨床症狀：(112/4/1)
 - i.新產生的 bone lesion(s)或 plasmacytoma；且須經病理切片證實。
 - ii.Plasmacytoma 體積增加 $\geq 50\%$ 。
 - iii.高血鈣(corrected serum calcium > 11.0 mg/dL 或 2.75 mmol/L)。
 - iv.貧血(Hemoglobin 下降幅度 ≥ 2 gm/dL 且無其他原因可以解釋)。
 - v.腎功能惡化(eGFR 需下降幅度 $\geq 25\%$)，且無其他原因可以解釋。
 - vi.出現其他 end-organ dysfunctions。
 - (2)再次申請時必須確定 paraprotein (M-protein)未上升(即表示對藥物有反應或為穩定狀態);或對部分 non-secretory type 多發性骨髓瘤病人以骨髓檢查

plasma cell 為療效依據，證明為對藥物有反應或為穩定狀態，方可繼續使用。續用時的申請以3個療程為限。疾病若發生惡化情形應即停止使用。

(107/1/1、112/4/1)

4. 每人終生以10個療程為上限，Pomado 則每人以6個療程為上限。(107/1/1、112/4/1、113/9/1)

5.不得與其他蛋白酶體抑制劑(proteasome inhibitor)或免疫調節劑(immunomodulatory drugs)併用。(109/2/1、112/4/1)

6.112年3月31日以前已核定用藥之病人，得經事前審查核准後，使用至總療程上限（即終生10個療程，Pomado 則每人6個療程）或使用期間發生疾病惡化為止。(112/4/1、113/9/1)

7.每日最多處方1粒(113/9/1)